

Información Paciente

Nombre : Ganina Raquel Tombolini Aedo
Edad : 69a 9m 14d
Dirección : Los Castaños 475

Rut : 6.729.633-8
Fecha Nacto: 14/11/1955
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2209011
Sexo : Femenino
Teléfono : 997792700

N° Epicrisis
452988

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad
Unidad de Egreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad

Fecha Ingreso : 20/08/2025 03:37
Fecha Egreso : 28/08/2025 15:08

Días Estadía : 8

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Dolor abdominal

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

INGRESO CIRUGÍA

ANTECEDENTES

Mórbidos: semipostrada por ACV secuelado (uso de silla de ruedas o carro de marcha), obesidad

Alergias: -

Quirúrgicos: cirugía por embarazo tubario (hace 40 años).

- infartos mesencefálico derecho, cerebeloso derecho y talámico derecho

- estenosis ateromatosa v4 y oclusión basilar desde tercio medio

- trombectomía mecánica tici 3, secuela fc izquierdo.

Fármacos: aas 100, atv 20, setralina 50mg al día, zopiclona en la noche, clonz 0.25

Hábitos: alcohol: (-); tabaco: (-); drogas: (-)

Paciente consulta por cuadro de 2 días de evolución de dolor abdominal epigástrico irradiado a hipocondrio derecho. Niega coluria, acolia, ictericia y fiebre. Sin nauseas ni vómitos. Refiere orinas de mal olor. Al interrogatorio por sistema refiere hace 7 días tos productiva escasa asociado a disnea hasta CF II, ingresa con requerimientos de O2 3 lts por NRC.

Exámenes de ingreso destaca GOT 59 GGT 114 GPT 36 FA 177 crea 0.93 lipasa 12 PCR 390 OC inflamatoria. TAC que evidencia signos de colecistitis aguda litiásica en evolución.

Ex físico:

Piel y mucosas hidratadas, normocoloreadas

Llene capilar <2 seg

RR2T no ausculto soplos

MP (+) disminuido, SRA

ABD RHA (+), abundante panículo adiposo, blando, depresible, doloroso a la palpación en flanco derecho. Murphy (+).

Genitourinario: SF (+)

EEII: simétricas, sin edema, sin signos de TVP. Pulsos pedios (+).

Diagnosticos de ingreso

1. Colecistitis aguda

2. Insuficiencia respiratoria aguda resuelta

Fecha Epicrisis : 28/08/2025 15:07

Fecha Última Actualización: 28-08-2025 15:07:35

Página 2 de 2

- NAC
- 3. ITU
- 4. RAM eritematoso - ATB?
- 5. Antecedentes

Paciente evoluciona hemodinamicamente, estable, normotensa, normocárdica, eupneica, logra destete de O2 con buena mecánica ventilatoria, afebril. Vigil, tranquila. Refiere dolor en hipocondrio derecho. PPil a la baja con ATB ceftriaxona-metronidazol. Eco mege confirma diagnóstico de colecistitis aguda, vía biliar fina. Se decide manejo quirúrgico dado estabilización de patologías con manejo médico. Se realiza colecistectomía laparoscópica el 23/08, procedimiento sin incidentes.

Es evaluada por neurología, impresiona solo secuelas crónicas, sin nuevo déficit objetivo, se sugiere control neurología ambulatorio habitual, sin indicación de permanecer hospitalizada por Neurología.

Diagnóstico de Egreso

CALCULO DE CONDUCTO BILIAR CON COLECISTITIS -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente evoluciona en buenas condiciones generales, HDN estable, afebril, normocárdica, con requerimientos de O2 en descenso hasta lograr suspensión. Dolor abdominal leve en zona operatoria, diuresis (+), deposiciones (-), tránsito a gases (+). Se retira drenaje sin incidentes. En condiciones de alta y continuar seguimiento ambulatorio.

Plan Post Alta

Reposo relativo
Régimen liviano
Mantener parches limpios y secos
Paracetamol 500 mg. 1 comp. cada 8 horas vía oral por 7 días
Ketoprofeno 50 mg. 1 comp SOS máximo cada 8 horas vía oral por 3 días máximo
Amoxicilina/Ácido clavulánico. 1 comp cada 8 horas vía oral por 3 días
Omeprazol 20 mg. 1 comp al día vía oral por 3 días
Clorfenamina 4 mg. 1 comp cada 8 horas vía oral por 5 días
Lágrimas artificiales 1 gota por cada ojo cada 8 horas por 10 días
Control en CDT pasillo 11 jueves 4 de septiembre 11:30 hrs con Dra. Villablanca. Acudir con epicrisis
Controles con neurología ambulatoria habituales
Consultar en SU si dolor intenso abdominal, dificultad para respirar, fiebre, secreción purulenta por herida, vómitos profusos o cuando estime conveniente

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos :

Controles

INTERNO


Paula Villablanca Pedrero
Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 28/08/2025 15:07

Página 2 de 2

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:12

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar